

**ITEM 352 : PERITONITE AIGUË**

**Péritonite** = inflammation aiguë du péritoine, localisée ou généralisée, de cause le plus souvent infectieuse

- **Péritonite localisée** = dissémination microbienne → dilatation capillaire et augmentation de la perméabilité péritonéale → épanchement liquidien septique : peut guérir spontanément, rester localisée (**plastron** ou **abcès**) ou se généraliser
- **Péritonite généralisée** : - FdR : concentration élevée de micro-organismes, immunodépression, germes virulents
  - **Séquestration liquidienne** → déshydratation, insuffisance rénale fonctionnelle
  - **Hyperperméabilité péritonéale** avec **libération d'endotoxines** → **choc septique**, **SDRA**, **nécrose tubulaire aiguë**, **CIVD**, **embole septique**, **thrombose portale septique** (**pyléphlébite**)

- **Péritonite généralisée** : - FdR : concentration élevée de micro-organismes, immunodépression, germes virulents
- **Séquestration liquidienne** → déshydratation, insuffisance rénale fonctionnelle
- **Hyperperméabilité péritonéale** avec **libération d'endotoxines** → **choc septique, SDRA, nécrose tubulaire aiguë, CIVD, embolie septique, thrombose portale septique (pyléphlébite)**

- **Hyperperméabilité péritonéale** avec libération d'endotoxines → choc septique, SDRA, nécrose tubulaire aiguë, CIVD, embole septique, thrombose portale septique (pyléphlébite)

- **Hyperperméabilité péritonéale** avec libération d'endotoxines → choc septique, SDRA, nécrose tubulaire aiguë, CIVD, embole septique, thrombose portale septique (pyléphlébite)

|                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| CLASSIFICATION DE HAMBOURG | Péritonite primaire                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Infection spontanée mono-bactérienne du péritoine, d'origine hématogène ou par translocation<br>- Infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique<br>- Infection à staphylocoque sur cathéter chez le patient dialysé péritonéale<br>- Péritonite spontanée à pneumocoque de l'adulte |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
|                            | Péritonite secondaire<br><br>(90%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infection/perforation intra-abdominale                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Post-opératoire                                            |  |  |
|                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Appendicite<br>- Diverticulite sigmoïdienne<br>- Perforation d'ulcère gastroduodénal<br>- Cholécystite<br>- Infarctus mésentérique<br>- Perforation digestive tumorale ou diastatique en amont d'un obstacle<br>- Colite : maladie de Crohn, RCH, typhoïde...                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Désunion anastomotique<br>- Contamination per-opératoire |  |  |
|                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Post-traumatique                                           |  |  |
|                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Plaie pénétrante<br>- Traumatisme fermé : perforation ou ischémie digestive<br>- Perforation endoscopique ou corps étranger                                                                                                                                                                     |                                                            |  |  |
|                            |                                    | Péritonite tertiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Infection abdominale persistante malgré un traitement bien conduit (antibiothérapie adaptée et éradication du foyer primitif abdominal par une ou plusieurs interventions) : surinfection de la cavité abdominale par des micro-organismes peu virulents mais devenus résistants ou des levures |                                                            |  |  |
| Diagnostic                 | C                                  | - Douleur abdominale : intense, généralisée ou parfois localisée, de début brutal ou progressivement croissante, accompagnée ou non de signes infectieux (fièvre, frissons...) selon la cause<br>- Signes d'irritation péritonéale : - Contracture : contraction rigide, tonique, invincible, permanente et douloureuse des muscles abdominaux<br>- Défense (contracture atténuée)<br>- Douleur aiguë à la palpation du cul-de-sac de Douglas au TR<br>- Douleur vive lors de la décompression brutale d'une fosse iliaque<br>→ Les signes péritonéaux peuvent être modérés, voire absent (notamment chez le sujet âgé ou dénutri, ou le nourrisson) ou difficiles à évaluer (notamment chez un patient obèse ou dans le coma)<br>- Recherche de signes de gravité → intervention en urgence sans examen complémentaire en cas de choc |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
|                            | Bio                                | = NFS, bilan de coagulation, groupage sanguin, ionogramme, bilan rénal, GDS, hémocultures<br>- Recherche de signes de gravité : insuffisance rénale, déshydratation, acidose métabolique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
|                            | PC                                 | → Le diagnostic de péritonite est clinique : les examens complémentaires en précise l'origine et la prise en charge, mais ne doivent pas retarder le traitement, et leur normalité ne doit pas faire remettre en cause le diagnostic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
|                            |                                    | ASP + RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Pneumopéritoine : croissant clair gazeux sous-diaphragmatique uni- ou bilatéral (perforation)<br>- Epanchement liquidien associé : niveau hydro-aérique sous-diaphragmatique<br>- Souvent accompagné de signes d'iléus avec dilatation gazeuse du grêle                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
| Etiologie                  | Scanner abdominal ± injecté        | = Utile : - En cas d'examen clinique douteux (immunodéprimé, péritonite asthénique du vieillard) ou difficile (obèse, péritonite post-opératoire, traumatisé de l'abdomen)<br>- Avant chirurgie si patient stable (permet d'orienter le geste)<br>- Pneumopéritoine (meilleure sensibilité que l'ASP), épanchement liquidien intra-abdominal<br>- Signe étiologique : diverticulite, infiltration péri-appendiculaire...<br>→ De plus en plus souvent réalisé en 1 <sup>ère</sup> intention avant l'ASP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |  |  |
|                            | Causes principales                 | Début                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximum des signes péritonéaux                                                                                                                                                                                                                                                            | Fièvre/hyperleucocytose                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pneumopéritoine                                            |  |  |
|                            | Appendiculaire                     | Progressif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fosse iliaque droite                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NON                                                        |  |  |
|                            | Perforation d'ulcère               | Brutal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epigastre                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NON au début                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUI                                                        |  |  |
|                            | Perforation de diverticulite       | Progressif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fosse iliaque gauche                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUI                                                        |  |  |

|                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiologie                       | Perforation d'ulcère gastrique ou duodénal                                                                                             | = Tableau péritonéal sans fièvre et avec pneumopéritoine<br>- Contexte : antécédent d'ulcères, prise de médicament gastro-toxique (AINS ++)<br>- Douleur épigastrique de début brutal, diffusant ensuite à tout l'abdomen<br>- Absence de fièvre (ou de syndrome inflammatoire biologique) < 24h : <b>péritonite chimique</b><br>- Contracture généralisée, ou localisée épigastrique avec défense dans le reste de l'abdomen<br>- Percussion : tympanisme pré-hépatique (pneumopéritoine)<br>→ L'endoscopie digestive haute est formellement contre-indiquée                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Péritonite diverticulaire                                                                                                              | = <b>Péritonite généralisée d'emblée</b> (perforation brutale : péritonite en 1 temps) ou par <b>perforation 2<sup>ndr</sup> d'un abcès péri-sigmoïdien</b> compliquant une diverticulite (péritonite en 2 temps)<br>- Douleur de la fosse iliaque gauche dans un contexte infectieux<br>- <b>Signes péritonéaux dans un 2<sup>nd</sup> temps</b> : douleur généralisée, syndrome infectieux marqué<br>- <b>Signes de choc</b> (notamment en cas de péritonite stercorale, fréquente)<br>- Contracture généralisée ou localisée de la FIG avec défense des autres quadrants, TR douloureux<br>- ASP/RP : <b>pneumopéritoine</b> (souvent volumineux et bilatéral), <b>iléus paralytique</b><br>- TDM : diverticulite = infiltration de la graisse péri-sigmoïdienne, abcès, liquide intra-abdominal |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Péritonite appendiculaire                                                                                                              | = <b>Péritonite généralisée d'emblée</b> ou <b>en 2 ou 3 temps</b> (complique un abcès ou un plastron)<br>- Sujet jeune avec douleur de la FID progressivement croissante, fébricule<br>- Secondairement : douleur intense et généralisée à tout l'abdomen<br>- ASP : ∅ pneumopéritoine (le bas fond caecal ne communique pas avec la cavité péritonéale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Péritonite post-opératoire                                                                                                             | = Fuite d'une anastomose digestive ou plaie opératoire méconnue de l'intestin : à <b>J5-J7 ++</b><br>- Diagnostic souvent compliqué: douleur attribuée à l'opération ou masquée par l'antalgie, iléus imputé à l'opération, syndrome inflammatoire imputé à l'opération ou à une autre cause post-op<br>→ A évoquer devant : - <b>Fièvre</b> survenant quelques jours après une chirurgie abdominale<br>- <b>Dégradation inexpliquée des fonctions vitales</b><br>- <b>Scanner avec opacification digestive</b> : réalisé en l'absence d'autre cause de fièvre évidente                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
| TTT des péritonites secondaires | → <b>Urgence chirurgicale</b><br>- Mise en conditions : pose de 2 VVP, réhydratation IV, correction des troubles hydro-électrolytiques |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Antibiothérapie IV                                                                                                                     | Non compliquée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - En 1 <sup>ère</sup> intention : <b>C3G + métronidazole</b> ou <b>Augmentin® + gentamicine</b><br>- Alternative si allergie : <b>lévofloxacine + gentamicine + métronidazole</b>                                                            |
|                                 |                                                                                                                                        | Sepsis grave/choc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - <b>Pipéracilline-tazobactam ± gentamicine</b> si choc septique<br>± <b>Antifongique</b> si ≥ 3 FdR : - Choc septique - Chirurgie sus-mésocolique<br>- Femme - Antibiothérapie depuis > 48h                                                 |
|                                 |                                                                                                                                        | - <b>Adaptée secondairement</b> à l'hémoculture ou au prélèvement per-opératoire<br>- <b>Durée courte</b> : - <b>48h</b> si péritonite localisée<br>- <b>5 jours</b> si péritonite généralisée<br>- Jusqu'à <b>8 jours</b> si sévère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | TTT chirurgical                                                                                                                        | - Abord : - Par <b>laparotomie médiane</b> généralement<br>- Possible par <b>coelioscopie</b> : péritonite non grave appendiculaire ou par perforation d'ulcère<br>- <b>Exploration complète</b> et <b>prélèvements bactériologiques multiples</b><br>- Traitement d'une perforation digestive selon la cause : <b>appendicectomie, suture d'ulcère, résection intestinale sans rétablissement de continuité d'emblée (intervention de Hartmann)</b><br>- <b>Lavage abondant de la cavité abdominale</b> avec plusieurs litres de sérum tiède ± <b>drains abdominaux</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Surveillance                                                                                                                           | - Signes généraux : hémodynamique, diurèse, fonction ventilatoire, fièvre<br>- Signes locaux : reprise du transit, disparition des signes péritonéaux<br>- Biologique : normalisation des PNN et de la fonction rénale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autres formes                   | En l'absence d'amélioration                                                                                                            | - Conséquence toxique : <b>SDRA, nécrose tubulaire aiguë</b><br>- <b>Abcès résiduel</b> (notamment sous phrénique ou Douglas)<br>- <b>Antibiothérapie inadaptée ou posologie insuffisante</b><br>- <b>Lâchage de suture</b><br>- <b>Infection urinaire ou sur cathéter</b><br>- <b>Accident thromboembolique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Péritonite primaire                                                                                                                    | = TTT médical : <b>hospitalisation et antibiothérapie probabiliste</b> en attendant l'antibiogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dialysé péritonéal = Généralement à <b>staphylocoque, BGN</b> ou <b>Candida</b> :<br>- <b>Application intra-péritonéale de vancomycine + aminoside</b><br>- Discuter <b>l'ablation du cathéter de dialyse</b> en l'absence de réponse en 48h |
|                                 | Péritonite tertiaire                                                                                                                   | - Patient souvent en <b>défaillance viscérale multiple</b> (intubés-ventilés, en réanimation)<br>- <b>Microorganismes</b> : <b>nosocomiaux</b> , souvent multi-résistants, difficile à traiter → <b>30% de mortalité</b><br>- <b>TTT chirurgical souvent impossible</b> (état général ou état local) → <b>radiologie interventionnel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |